

# Brain & Mind

## Morning Conference Case

가성 치매를 정확히 진단받고 치매 증상에서 해방된 72세 여성  
김희진 / 한양대학교병원

1년 전부터 진행하는 기억력 저하로 내원한 82세 여성  
왕민정 / 로아신경과의원

우울증이 동반된 혈관성 인지장애를 호소하는 74세 남성  
양영순 / 순천향대학교 천안병원

# 가성 치매를 정확히 진단받고 치매 증상에서 해방된 72세 여성

## 증례

72세 여성이 최근 6개월간 진행된 기억력 저하와 일상 기능 저하를 주소로 신경과 외래를 방문하였다. 고졸 학력이며, 남편과 사별 후 수년째 홀로 거주하고 있다.

환자 자신은 “기억력이 심하게 나빠져서 아무것도 못하겠다”, “자꾸 물건을 잃어버린다”, “사람들을 만나고 싶지 않다”고 표현하였다. 보호자는 환자가 점점 말수가 줄고, 평소 즐기던 TV 시청도 하지 않으며, 식사량이 감소하고, 밤에 잠을 이루지 못하는 모습을 보였다고 보고하였다. 최근에는 “나는 쓸모없는 사람”이라는 부정적인 언어 표현도 자주 반복하였다. 병력 상 10년 전부터 고혈압을 안정적으로 조절 중이며, 3년 전부터 우울증으로 치료를 받아 오다 최근 수개월간 우울증약 복용을 중단하였다. 그 외에 인지 기능에 영향을 줄 만한 특이 병력은 없었다.

## 평가 및 신경심리 검사 결과

신경학적 진찰에서 국소신경학적 이상 소견은 없었으며, 보행 및 일상 생활 동작에도 이상은 관찰되지 않았다.

MMSE(mini-mental state examination) 총점 21점으로, 지남력(orientation), 주의력(attention), 단기 기억(immediate recall) 영역에서 두드러진 저하가 있었다.

영상 및 혈액 검사를 보면 뇌 MRI에서 정상 노화 소견 외 명확한 위축 소견은 없으며, 해마나 측두엽의 구조적 이상도 관찰되지 않았고, 백색질변성도 명확하지 않았다(그림 1). 아밀로이드 핵의학 검사에서도 전 영역에 걸쳐서 composite centiloid 값이 -5.7으로 정상이었다. 혈청 검사에서 비타민 B12, 엽산 수치는 정상 범위였고, 갑상선 기능(TSH, free T4), 전해질, 간·신장 기능 등은 모두 정상이었다. 또한 신경매독을 포함한 다른 감염성 및 대사성 질환들은 모두 배제되었다.

정밀 신경심리 검사에서는 인지 영역 전반에 걸쳐 고른 저하가 관찰되었으며, 특히 검사 수행에 있어 노력 부족, 비협조적 태도가 두드러졌다. 주어진 과제에 대해 “기억이 전혀 나지 않는다”며 포기하는 경향이 많았고, 인출(retrieval)이 어려운 delayed recall 과제에서도 힌트(cue)를 제공하면 정답을 회복하는 양상이 관찰되었다. 이러한 소견은 정보 저장의 결함이 아니라 인출 과정의 장애를 시사하며, 이는 알츠하이머병(AD)과 같은 진성 치매보다는 우울증에 의한 가성 치매에서 흔히 관찰되는 양상이다. 또한, 환자가 자신의 인지 저하에 대해 지나치게 걱정하며 반복적으로 언급하는 모습은, 알츠하이머병 초기 환자에서 자주 보이는 ‘질병 인식 결여

(anosognosia)’와는 구별된다.

## 최종 진단 및 치료 과정

이상의 결과를 종합하여 본 증례는 주요 우울장애(major depressive disorder, MDD)로 인한 가성 치매(cognitive impairment reversible dementia, CIRDD)로 진단하였다.

치료는 SSRI 계열 항우울제(sertraline 25 mg/day, 이후 50 mg/day로 증량)를 중심으로 시행하였으며, 지역 정신건강복지센터와 연계하여 정기적인 방문 면담, 정서적 지지 및 사회적 재활 활동 참여 유도 등의 정신사회적 중재도 병행하였다. 항우울제 복용 6주차부터 점진적으로 기분이 호전되었고, 외출 횟수 증가, 식사량 회복, 일상 생활 참여 증가 등의 긍정적 변화가 나타났다. 3개월 후 외래 방문 시 MMSE는 27점으로 회복되었으며, 신경심리 검사에서도 전반적 인지 기능이 정상 범위로 호전되었음을 확인하였다. 환자는 TV 시청, 가족과의 전화 통화, 종교 활동 등 평소 즐기던 활동을 재개하였으며, “요즘은 머리가 훨씬 맑아졌다”고 말할 정도로 자각적 인지도 회복되었다.

## 고찰

고령화의 가속화와 더불어 인지 기능 저하를 호소하는 환자의 수가 급증하고 있

다. 일반적으로 치매(dementia)는 비가역적이고 진행성인 신경퇴행질환으로 인식되지만, 일부 환자에서는 가역적인 인지 기능 저하가 관찰된다.<sup>1</sup> 이러한 CIRD는 근본 원인에 따라 치료가 가능하며, 조기 인지와의 적절한 개입을 통해 기능적 회복을 기대할 수 있다. 가성 치매는 주로 주요 우울장애에 이차적으로 발생하며, 인지 기능 저하가 뚜렷함에도 불구하고 항우울 치료 후 인지 기능이 호전되는 양상을 보이는 것이 특징이다. 그러나 실제 임상에서는 우울 증상이 경미하거나 명확히 표현되지 않는 경우가 많아, 퇴행성 치매로 오진되는 사례도 적지 않다. CIRD는 임상적으로 치매와 유사한 인지 기능 저하를 보이

지만, 근본 원인이 치료 가능하고 이에 따라 인지 기능이 회복되는 상태를 의미한다. 흔히 '가성 치매(pseudodementia)'라는 용어로도 알려져 있다.

중등도 인지 기능 저하를 주소로 내원한 고령 환자에서 AD가 아닌, 주요 우울장애에 이차적인 가성 치매로 진단된 증례로, 고령 환자에서 인지 기능 저하가 반드시 알츠하이머병(AD)과 같은 퇴행성 치매로 귀결되는 것이 아니라 가역적이며, 치료 가능한 상태, 즉 우울증성 가성 치매일 수 있음을 시사한다. 특히 주요 우울장애에 이차적으로 발생하는 가성 치매는 실제 임상에서 흔히 간과되며, 그로 인해 불필요한 치매 진단 및 예후 판단 오류가 발생

할 수 있다.

본 증례에서 환자는 서서히 진행되는 저장 손상의 양상을 보이지 않았고, 지연 회상(delayed recall) 시 단서 제시에 호전되는 양상을 보였다. 이는 AD에서 흔히 관찰되는 단서에 반응하지 않는 기억장애와는 명확히 구별되는 특징이다. 또한 국소적 신경학적 결손이나 과거 뇌혈관질환 병력이 없어 혈관성 치매 가능성도 낮았으며, 약물 복용력이나 대사성 질환(갑상선 기능 저하, 비타민 B12 결핍) 등 인지 저하를 유발할 수 있는 기타 원인들 역시 배제되었다.

우울증 치료 후 인지 기능의 유의미한 회복이 관찰되었다는 점은, 본 증상이 기분장애에 이차적인 인지 저하였음을 강하

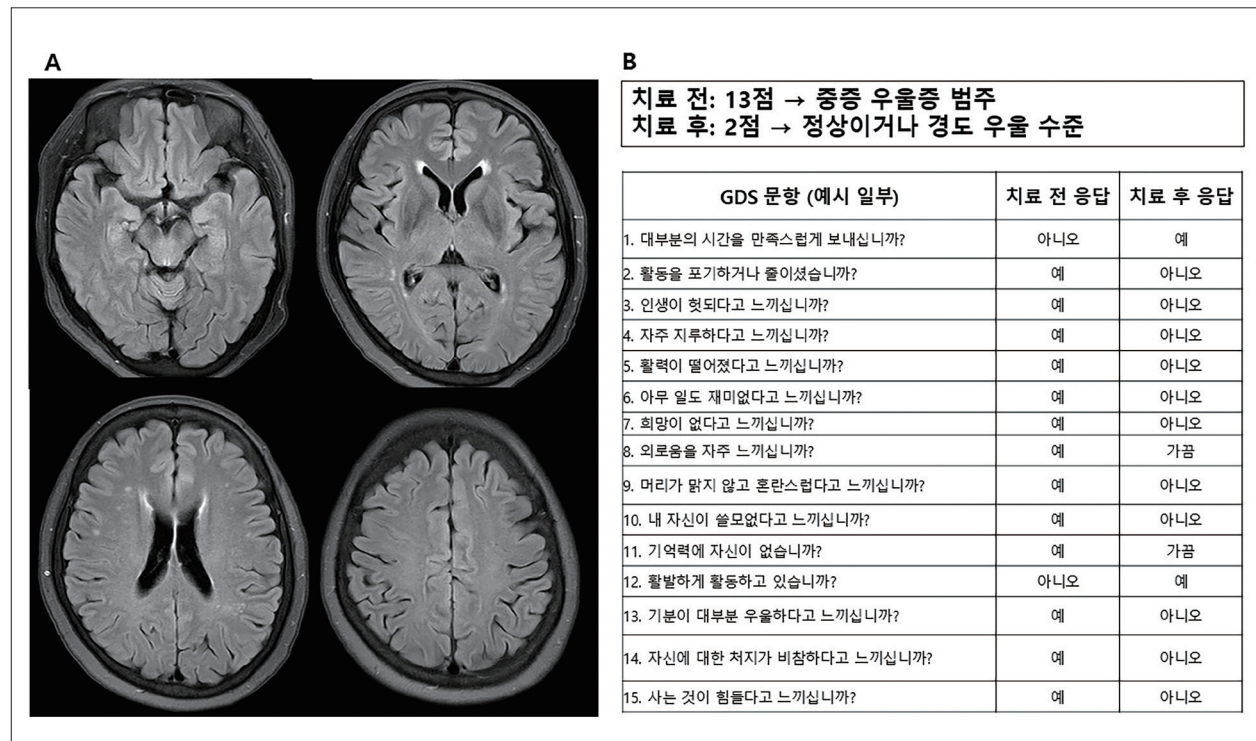


그림 1. (A) Brain MRI(FLAIR image). There is no abnormal finding on FLAIR image  
 (B) Geriatric Depression Scale – short version. There was significant improvement on her depression score

게 시사한다. 이와 같이 우울증성 가성 치매는 조기 인식과 적극적인 개입을 통해 충분히 회복 가능한 임상적 양상이므로, 고령 환자에서 인지 저하를 주소로 내원한 경우 다음과 같은 감별 진단 접근이 필수적이다.

- 1) 정밀 신경심리 검사 및 단서 제시에 대한 반응 분석
- 2) 정서 상태 평가(예: geriatric depression scale, GDS)
- 3) 뇌 구조 영상 및 대사·내분비적 검사를 포함한 이차적 원인 배제
- 4) 자세한 병력 청취 및 보호자 보고 확인

이러한 다각적 평가를 통해 오진을 줄이고, 치료 가능한 인지 저하를 조기에 발견하여 삶의 질을 향상시킬 수 있다.

## References

1. Sachdev, P. S., & Malhi, G. S. (2002). Pseudodementia: A clinical update. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 36(5), 507–15.

# 1년 전부터 진행하는 기억력 저하로 내원한 82세 여성

## 증례

82세 여성이 1년 전부터 서서히 진행하는 기억력 저하로 내원하였다.

환자는 대졸자로 실버타운에서 거주하며, 5년 전 남편과 사별 후 혼자 살고 있었다. 대화 내용을 잊어버리며, 특히 단어가 잘 생각나지 않고, 가끔은 누구와 어떤 주제로 대화한지도 생각나지 않을 때가 있다고 하였다. 정신이 없어 일정을 잊어버린 적이 있지만 당일에 놓친 적은 없고, 약 복용도 스스로 하지만, 가끔 먹었는지 헷갈리는 경우가 있다고 하였다. 병원 방문 시 진료 중인 과와 다녀온 일자와 요일을 헷갈려 했지만, 대략적으로 기억하는 편이었다. 스스로 기억력에 대해 걱정이 많아 치매에 걸릴까 봐 불안하다고 하였다.

3~4년 전까지 운전을 하다가 순발력이 떨어지고 주차를 하다 옆 차를 긁어 그만 두었다고 하며, 일정하게 자주 가는 곳은 잘 다니지만 새로운 곳은 방향이 잘 안 잡혀 헤매는 경우가 있다고 보고하였다. 재정 관리를 스스로 하며, 은행업무도 ATM이나 창구에서 큰 문제없이 수행한다고 하였다. 가끔 반찬을 사거나 생필품 등 많은 물건을 사는 데에 있어 거스름돈 계산 등에는 큰 문제는 없었고, 테블릿 PC와 휴대전화 등 가전제품 사용에도 지장이 없었다.

정밀인지 검사에서 MMSE 27점, CDR 0.5, SOB 2.0, GDS 3점이었으며, 언어적

기억력 및 전두엽 기능의 저하가 관찰되었고(그림 1), short geriatric depression score에서 9점으로 우울증에 해당하였다.

MRI에서 특별히 해마위축이나 소혈관

질환은 관찰되지 않았다(그림 2). 혈액 검사 상 ApoE e3/e3, 혈액 내 베타 올리고머 검사에서 0.42로 저위험군에 해당하였고, 갑상선 기능 검사, vitamin B12,

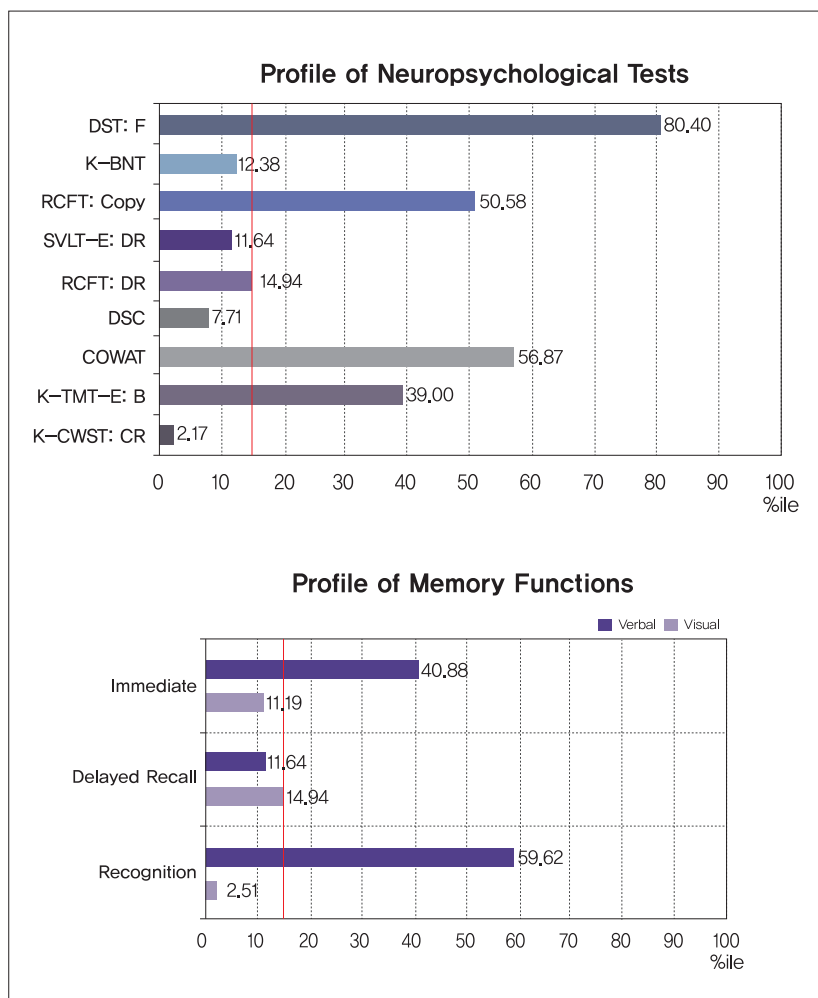


그림 1. 인지 기능 검사 결과표

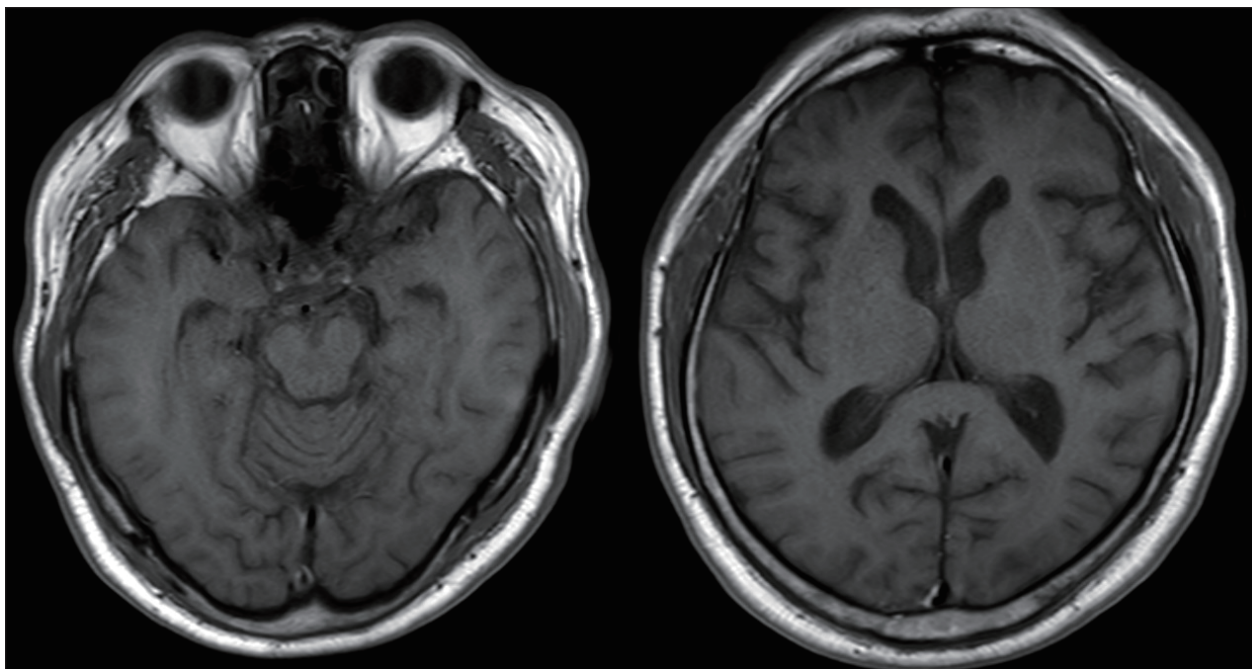


그림 2. MRI 영상 검사(T1 axial & coronal view)

folate, VDRL 등도 정상이었다. 이러한 결과를 바탕으로 cognitive impairment related depression으로 진단하였다. 환자는 lexapro를 복용하기 시작하였으며, 1개월 후부터는 기억력이 좋아지고 머리도 맑아지는 것 같다고 보고하였다.

## 고찰

노년기 우울증은 고령층에서 가장 흔하게 발생하는 정신질환 중 하나로, 신체질환 및 사회경제적 스트레스와 밀접하게 연관되어 있다. 은퇴, 경제적 어려움, 배우자나 지인의 상실, 신체 기능 저하 등 다양한 요인이 노년기 우울증의 발병 위험을 높인다. 이러한 우울증은 높은 재발률과 자살률을 보이는 심각한 질환이지만, 조기 발견과 적절한 치료를 통해 충분히 관리 및 예방이 가능하다.

노년기 우울증의 중요한 특징 중 하나는 인지 기능 저하가 흔히 동반된다는 점이다. 이는 주관적인 인지 기능 저하 호소부터 객관적으로 측정 가능한 경도인지장애(MCI) 진단에 이를 수 있으며, 때로는 치매로 오인될 정도로 현저한 기억장애를 보일 수 있다. 노년기 우울증 환자의 약 40%가 경도인지장애 진단 기준을 충족하며, 경도인지장애 환자의 약 30%가 우울증을 앓고 있다는 보고도 있다. 이러한 인지 기능 저하는 노인의 삶의 질을 현저히 저하시키는 주요 요인으로 작용한다.

우울증으로 인한 인지 기능 저하를 진성 신경퇴행성 치매(예: 알츠하이머병, 혈관성 치매)와 정확히 구별하는 것은 예후와 치료 전략이 크게 다르기 때문에 매우 중요하다. 전자의 경우 기저 우울증의 효과적인 치료를 통해 가역적이거나 유의미

하게 호전될 수 있다. 중요한 감별점 중 하나는 환자가 자신의 인지적 어려움에 대해 얼마나 인지하고 있는 가이다. 진성 신경퇴행성 치매 환자는 종종 자신의 기억 문제에 대한 인식이 부족하지만, 인지 검사에서는 저조한 수행을 보인다. 반면 우울증으로 인한 인지 기능 저하가 있는 환자는 자신의 기억 문제에 대해 광범위하게 호소하지만(주관적 인지 저하), 객관적인 인지 검사에서는 상대적으로 더 나은 수행을 보이거나 수행이 일관되지 않을 수 있다. 알츠하이머병(AD)으로 인한 인지 저하의 경우 주로 일화 기억(새로운 정보를 학습하고 회상하는 문제)의 손상으로, 기억력 검사에서 새로운 정보를 등록하는 과정의 실패를 보인다. 반면 우울증으로 인한 경도인지장애의 경우 일반적으로 주의력, 처리 속도, 학습, 기억, 실행 기능 등 여러

영역에 걸쳐 인지 저하가 나타난다. 기억력 검사 시 저장장애보다는 인출장애의 특징을 보이는 경우가 많으며, 실행 기능의 저하도 함께 동반된다. 본 환자 역시 기억력과 언어 능력, 실행 기능에서 뚜렷한 저하가 있었으며, 일정 관리나 약 복용의 혼동이 발생하기도 하였다. 또한 환자 스스로 기억력 저하에 대한 걱정이 많은 편이었다. 그러나 일상적인 생활에서 큰 불편을 겪지 않으며, 가전제품 사용이나 은행 업무 등의 일상적인 과제에는 큰 어려움이 없었다는 점에서 경도인지장애(MCI)로 진단할 수 있었다. 경도인지장애의 여러 원인을 확인하기 위한 뇌 영상 검사에서 해마 위축이나 소혈관질환이 발견되지 않았고, 혈액 내 베타 올리고머 검사와 ApoE 유전자 검사에서도 위험인자가 관찰되지 않아, 퇴행성 뇌질환의 가능성은 낮다고 판단하였으며, 최종적으로 우울증에 의한

인지 저하(cognitive impairment related depression)로 진단하였다.

우울증과 관련된 MCI는 흔히 “가역적”으로 간주되어 증상이 안정적으로 유지되거나 심지어 정상 인지 기능으로 회복될 수 있지만, 일부에서는 특히 초기 증상에서 더 심각한 인지 증상을 보이는 환자는 비가역적 치매로 진행한다. 이는 노년기 우울증의 첫 발병이 치매질환의 전조 증상(prodrome)일 수 있다는 점을 시사한다. 따라서, 적극적인 노년기 우울증 치료는 기분 증상 완화를 넘어 인지 기능 저하를 잠재적으로 지연시키거나 인지 기능 저하의 핵심적인 위험인자를 조절한다는 의미에서 반드시 필요하다. 즉, 노인 우울증은 단순히 정신 건강 문제가 아니라 장기적인 뇌 건강을 위해 적극적이고 공격적인 관리가 필요한 중요한 신경학적 위험인자로 인식되어야 한다.

우울증과 경도인지장애 모두에 대한 조기 진단 및 개입은 증상 관리, 기존 인지 능력 보존, 그리고 전반적인 예후 개선에 매우 중요하다. 기억 훈련, 생활습관 변화, 사회적 참여를 포함한 적극적인 조치는 경도인지장애의 진행을 늦추거나, 안정화시키거나, 심지어 역전시킬 수 있다.

양영순 / 순천향대학교 천안병원

# 우울증이 동반된 혈관성 인지장애를 호소하는 74세 남성

## 증례

74세 남성이 최근 기억력 저하와 말이 어눌해지는 증상으로 신경과 외래를 방문하였다. 환자는 대학교 졸업 후 중학교 교사로 근무를 하다가 은퇴하였으며, 현재는 아내와 함께 생활하고 있다. 환자의 배우자는 최근 수개월 사이에 환자가 대화 중 단어를 자주 잊고, 같은 말을 반복하며, 집 근처에서도 길을 잃는 일이 발생했다고 하였다. 또한, 성격 변화가 동반되어 이전보다 짜증이 많아지고 무뚝뚝한 태도를 보이기 시작했으며, 오른쪽 팔과 다리의 움직임이 예전보다 느려지고 서툴러졌다고 하였다.

과거에 비해 의욕이 뚜렷하게 감소하고 일상 생활에서도 무기력한 모습을 자주 보여 환자의 배우자는 “요즘 남편이 자주 멍하게 앉아 있고, 좋아하던 신문도 안 보고, 말도 거의 안 한다”며, 전반적인 감정적 활력의 상실과 대인 기피 경향을 걱정하였다.

표정은 무표정해졌으며, 말투는 느리고, 감정 표현이 줄어든 모습이라고 하였다. 외출을 꺼리고, 가족 모임이나 친구들과의 만남을 피하며, 침대에 누워 있는 시간이 많아졌다고 하였다.

고혈압을 15년간 앓고 있으며, 고지혈증도 7년 전부터 진단받아 약물 치료를 받고 있으나 생활습관 개선은 충분하지 않은 상태였다. 2년 전에는 우측 중대뇌동맥(MCA)

영역의 뇌경색 진단을 받은 병력이 있다.

과거 20년간 하루 한 갑씩 흡연하였으며, 최근 몇 년 전부터는 금연 중이다.

음주는 주 2회 정도 소주 1병 가량을 마시는 습관이 있다.

신경학적 진찰에서는 단기 기억력의 저하가 관찰되었으며, 시간과 장소에 대한 지남력 저하도 확인되었다. 계산 능력과 추상적 사고에 어려움을 보였으며, 경도 우측

편마비와 언어 유창성 감소(말을 더듬고 느려진 산출 속도)가 동반되어 있었다.

인지 기능 검사를 시행한 결과, K-MMSE (mini-mental state examination)에서 15점을 기록하였고, SNSB 검사 상 집중력, 기억력, 전두엽 기능에서 저하가 두드러졌으며, 전반적으로 중등도의 인지 기능 저하 소견을 보였다. Geriatric depression scale(GDS) 검사에서는 14점으로 노인 우울증 고위험군에 해

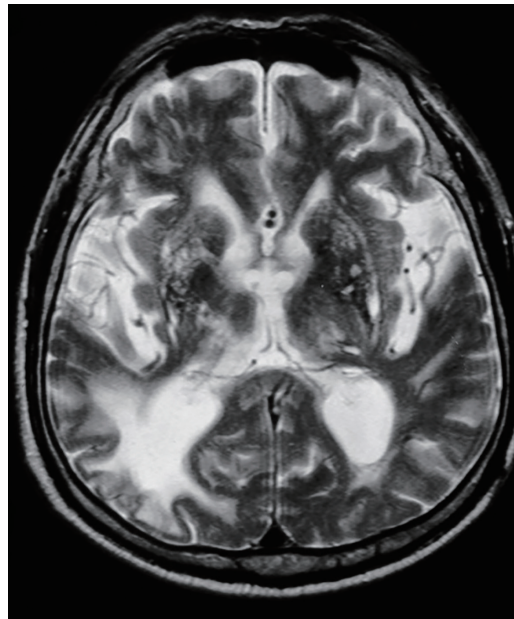


그림 1. Axial T2-weighted brain MRI showing multiple hyperintense lesions in the subcortical white matter, consistent with chronic lacunar infarcts and small vessel ischemic changes.

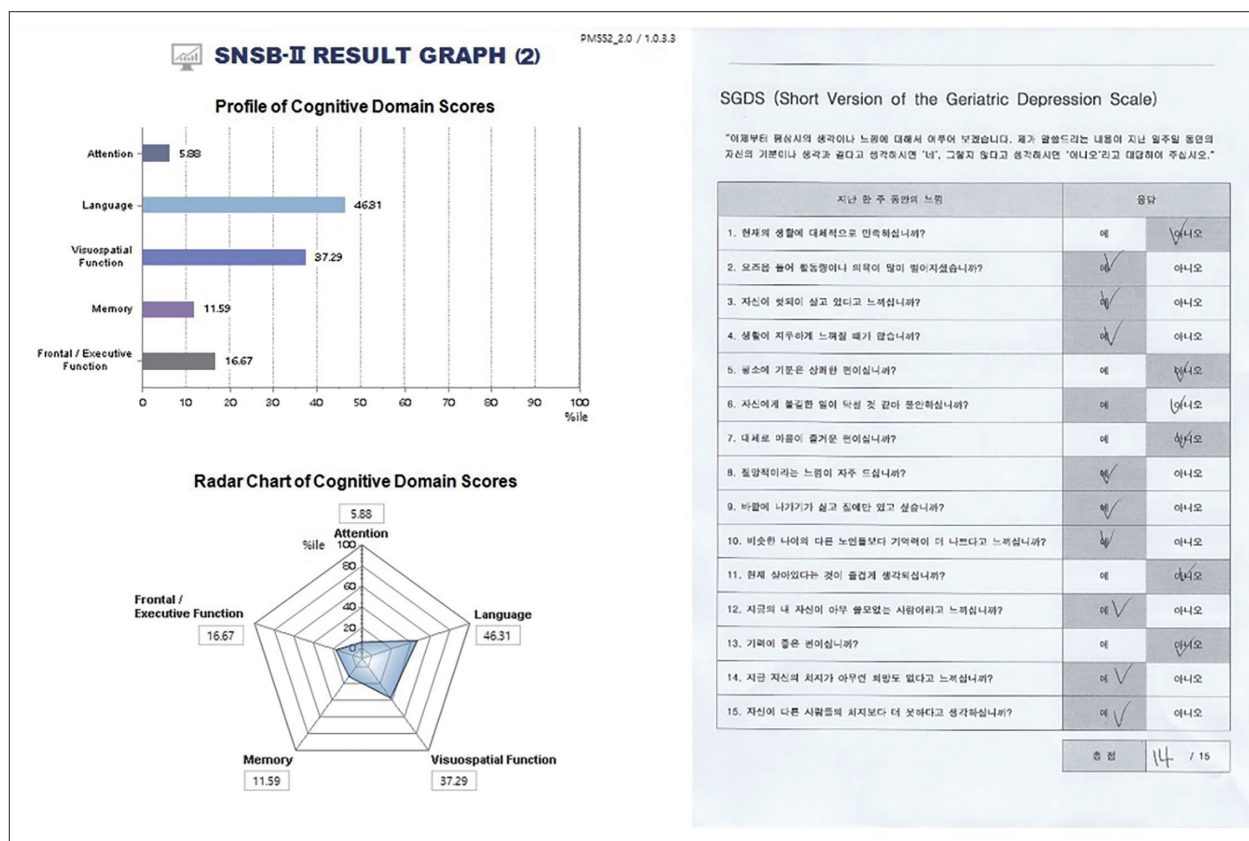


그림 2. Results of neuropsychological assessments conducted at hospital admission

당되었다.

뇌 MRI 검사에서는 과거 우측 중대뇌동맥 영역의 경색 흔적이 관찰되었으며, 백질 고강도 신호(leukoaraiosis)와 다발성 허혈성 변화가 확인되었다. 이러한 영상학적 소견과 임상 증상을 종합하여, 환자는 혈관성 치매로 진단되었다. 치료는 아세틸콜린 에스테라제 억제제(donepezil)를 시작하고, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 계열의 항우울제를 병용하였다.

복용 후 3개월 뒤 인지 기능 검사를 시행한 결과, K-MMSE에서 21점을 기록하였고, SNSB 검사 상 이전에 비해 많이 개선된 결과를 보였다. GDS 검사에서는 6점으

로 정상 범위에 해당되었다.

## 고찰

혈관성 우울증은 주로 노년층에서 관찰되는 주요 우울장애의 한 아형으로, 뇌혈관 질환의 존재 또는 뇌혈관 위험인자가 우울증의 발생 및 진행에 직접적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 특히, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 심혈관질환 등 전형적인 뇌혈관 위험인자를 동반한 노인 환자에서, 우울 증상이 비교적 늦은 시기에 발생하고, 전형적인 주요 우울장애와는 다른 양상과 경과를 보이는 경우 혈관성 우울증을 의심하게 된다.

병태생리학적으로 혈관성 우울증은 주로 뇌의 전전두엽 피질(prefrontal cortex)과 피질하 구조물(subcortical structures)을 연결하는 전두선조체 회로(frontostriatal circuits)의 손상과 관련이 깊다. 이 회로는 감정 조절, 동기 부여, 판단력 및 실행 기능 등을 담당하는데, 만성적인 뇌혈관 허혈, 특히 소혈관질환(small vessel disease)이나 반복적인 미세경색으로 인해 이 회로가 손상될 경우, 무감동(anhedonia), 실행 기능 저하, 정신 운동 둔화(psychomotor retardation) 등이 특징적으로 나타나게 된다. 이러한 병변은 T2-weighted 또는 FLAIR MRI에서 백질 고

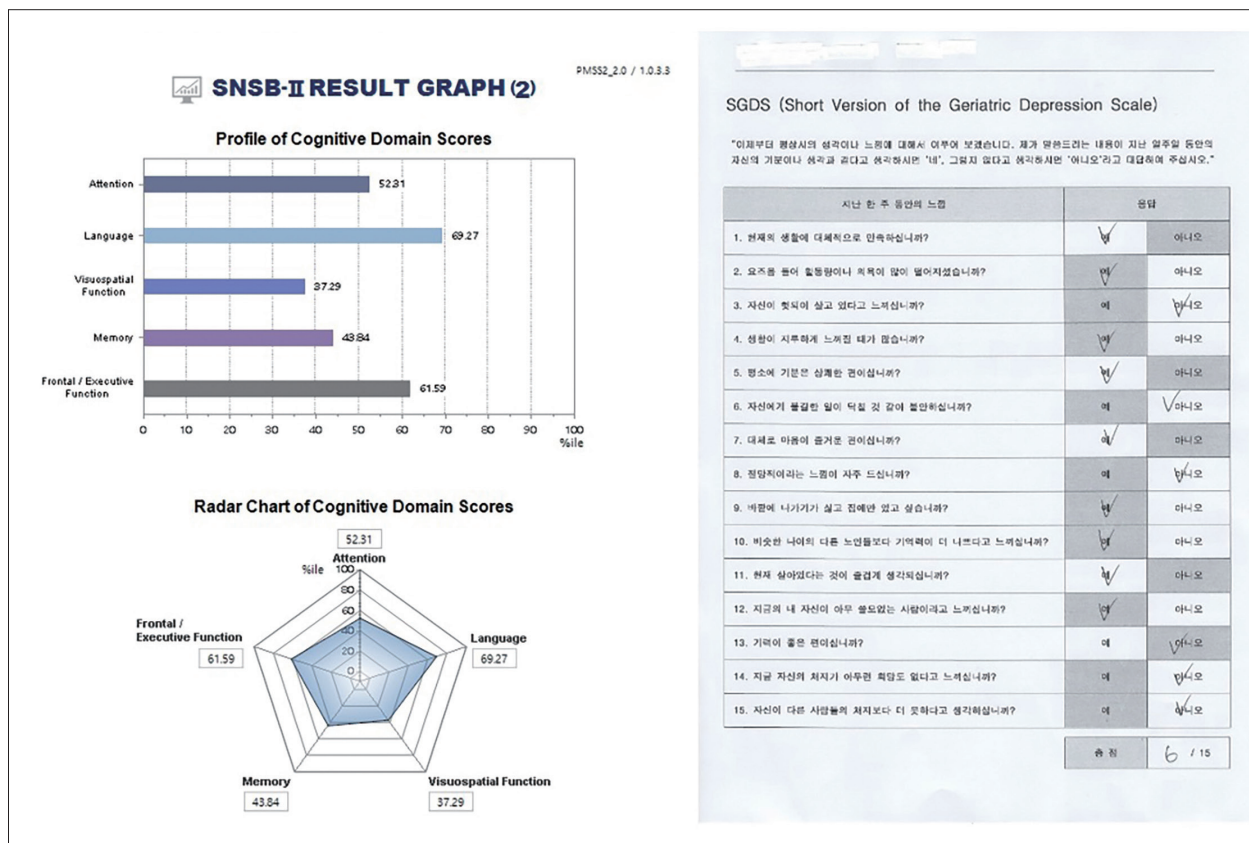


그림 3. Neuropsychological test results at 3-month follow-up

강도 신호(white matter hyperintensity, WMH)로 관찰되며, 이는 소혈관 허혈성 병변의 영상학적 표현으로 간주된다.

임상적으로 혈관성 우울증은 전통적인 주요 우울장애와 비교하여 다음과 같은 차이점을 보인다. 첫째, 증상의 발병 시점이 60세 이후의 늦은 시기(late-onset depression)이며, 가족력보다는 신체적, 특히 혈관성 위험인자의 영향이 더 크다. 둘째, 기분 저하보다는 감정 둔마, 의욕 저하, 무감동 등이 더 전면에 나타나고, 자책이나 죄책감보다는 '무의미감'이나 '허무함'을 표현하는 경향이 있다. 셋째, 주의력 감소나 계획력 저하 등 실행 기능(executive

function)의 장애가 두드러지며, 이는 일상 생활 수행에도 뚜렷한 영향을 미친다. 넷째, 항우울제에 대한 반응 속도가 느리고, 완전한 회복을 또한 낮은 것으로 보고된다.

진단은 DSM-5에서 정의하는 주요 우울장애(major depressive disorder)의 기준을 충족하는 동시에, 영상학적으로 백질 변화 또는 소혈관 허혈성 병변이 확인되고, 혈관성 위험인자가 존재하며, 실행 기능 저하가 동반된 경우 임상적으로 혈관성 우울증으로 간주할 수 있다. GDS나 Hamilton depression rating scale(HDRS) 등을 활용한 평가 외에도, 간이정신상태 검사(MMSE)와 montreal cognitive assessment(MoCA)를

통해 동반된 인지 기능 장애 여부를 파악하는 것이 진단에 도움이 된다. 우울증이 동반된 혈관성 인지장애 환자의 경우 이 환자처럼 항우울제 복용으로 인지 기능이 많이 개선될 수 있으므로 반드시 우울증 검사는 시행하는 것을 추천한다.